جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حنان احمد عوض احمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** ===
رقم البطاقة : 27901252102689 **رقم التليفون :** 01008447025 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-01-1979 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالمبيض
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : ورم خبيث بالمبيض
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: حنان احمد عوض احمد
National ID: 27901252102689

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

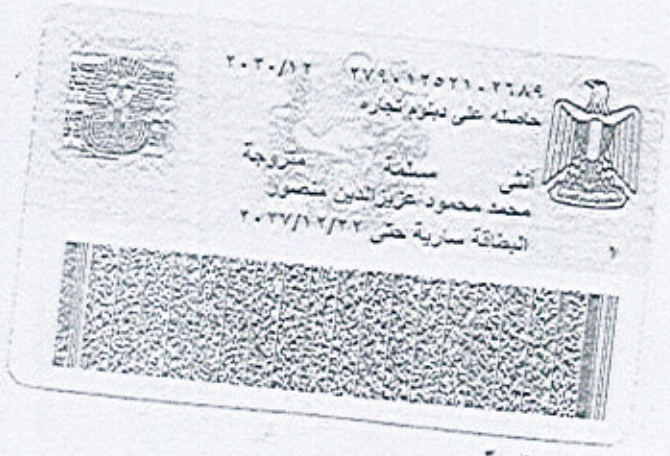
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of ovarian cancer for Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: حنان احمد عوض احمد **MR. :** 4730	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a history of endometrial cancer diagnosed in 2019, for which magnetic resonance imaging of the abdomen and pelvis with contrast has been performed.

During follow-up of the endometrial cancer diagnosed in 2019, the internal medicine team documented that there is no indication for zoledronic acid (Zometa) at this time and questioned the rationale for its use, noting the absence of a multidisciplinary team recommendation.

After oncology consultation, the plan was to administer zoledronic acid today and to obtain a dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan first in order to determine whether zoledronic acid is indicated.

Neck ultrasound demonstrated right thyroid lobe nodules classified as TIRADS 2 and left thyroid lobe nodules classified as TIRADS 1. The recommendation is to obtain a thyroid function profile and to arrange an endocrinology consultation to evaluate the patient’s symptoms.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : mohamed ismael

يعتمد ,

Pathology Report

Name: [illegible] Age: 46 years.

Clinical data: Right adenexal mass.

Specimen type: Panhysterectomy & appendicectomy

Date: 8/5/2019

Lab. Number: 367 Hospital Number: 1196/2019

Gross Description:

Four specimens were received designated as:

A) Panhystectomy specimen :

corpus 4.5x4x2.5 cm, cervix 3cm long, 1.5 cm long thickness, 0.6cm external os diameter. Endometrial thickness;0.1 cm. Myometrial thickness;2cm. Right tubo-ovarian complex measured 5x4x2.2 cm. Left tube 6.5 cm. Left ovary: 2.3x1.8x1 cm. Cervix shows nabotheian cysts.

Right ovary shows firm greyish tan tissue with associated cyst formed of smooth congested outer surface and hemorrhagic lining cyst measured 4x3x1.5 cm, yellowish lining for another one.

Right tube was distorted incorporated with right ovary and can't be detached well grossly.

Left ovary was partly replaced by multiple smooth partly hemorrhagic lining cysts.

B) Appendectomy specimen; 6.2x1.7x1 cm, outer surface was smooth partly congested at tip area, also seen a nodule attached to outer surface at tip area 0.6x0.3 cm, on opening it showed smooth lining and filled with fecal material. Base margin was viable and healthy. Average wall thickness 0.3cm.

C) Right omental lymph node; A flattened fibrofatty tissue piece; 4x3cm. entangling 5 nodules up to 1x0.5cm.

D) Right illiac lymph node; fatty tissue piece 3x2 cm entangling 2 nodules up to 1.2x0.6 cm.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: HNAN Ahmed	*Date of birth:* 25/01/1979
Arabic Name: حنان احمد	*Patient Gender:* F
Patient RIS ID: 339267	*Exam Date:* 12/10/2023
Patient HIS ID: 123021407	
Written by:	Approved by:
DR. Dina Ahmed Deif	DR. Dina Ahmed Deif

Patient's Name: hanan ahmed awad
Hospital number:123021407

F18-FDG PET/CT STUDY

CLINICAL HISTORY:
47 year-old female patient with managed ovarian cancer

TECHNIQUE:
Approximately 1hour following intravenous injection of the radiopharmaceutical fluoro-deoxyglucose (FDG), a total body PET-CT was acquired from base of skull to mid-thigh with the arms extended above the head. CT without contrast was acquired

NO IV contrast was administrated

Hepatic reference 3.8

Report

Head and Neck:

- No hypermetabolic FDG avid cervical lymph nodes detected.
- Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, thyroid gland and larynx.
- The brain shows uniform tracer distribution with no hypermetabolic focal lesions.

Chest:

- No hypermetabolic FDG avid mediastinal or axillary nodal lesions detected.
- No FDG avid lung nodules or masses detected
- There are no active pleural or pericardial abnormalities.

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

* Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

* FDG avid left external iliac LN 19mm with SUVmax 9.8
* Average sized liver with no FDG avid focal lesions.
* The spleen , pancreas show normal shape and normal FDG avidity.
* There are no active adrenal nodules.
* Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder.

Musculoskeletal:

* Normal FDG activity is seen in the axial skeleton. No focal active blastic or lytic lesions noted.

Conclusion

Positive study for FDG avid left external iliac nodal deposit.

Nuclear Medicine unit

Hoda fathy , MD
Dina Deif, MSc

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]